Türkçe YouTube Boyun Manipülasyonu Videoları — Çalışma ve Kodlama Kılavuzu

Sürüm 2.1 (pilot uzlaşısı sonrası) · 01.11.2026 · Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Cem Zafer Yıldır · Kodlayıcılar için

> **Önce bunu okuyun.** Bu belge çalışmanın tamamını anlatır. Kodlamaya başlamadan önce 4. ve 6. bölümleri, özellikle **6.7 Vaat listesini** mutlaka okuyun. Kuralda olmayan bir durumda kendi kuralınızı uydurmayın; notu "Açıklama" kutusuna yazın, uzlaşı turunda birlikte karar verilir.

> **Sürüm 2.1'de neler değişti (01.11.2026, pilot uzlaşısı sonrası)?** (1) **Hastalık adı kuralı kalktı:** başlık, açıklama ya da etikette yalnız hastalık adının geçmesi (fıtık, düzleşme, migren, kulak çınlaması dahil), anahtar sözcük dizileri ve etiketler vaat değildir; vaat için manipülasyonun bir sonuç sağladığını ya da bir mekanizmayla çalıştığını söyleyen bir ifade gerekir. Genel "çözüm" sözü de yetmez (6.7). (2) mDISCERN 2 ve JAMA Yazarlık'ta kanal adındaki **unvan ya da klinik/kurum adı** yeterlidir (6.8). Ses kuralı (söz yoksa D7 yok) aynen geçerlidir.

> **Sürüm 2.0'da neler değişti (31.10.2026, pilot sonrası)?** Kuralların özü aynı; pilotta farklı uygulanan kurallar açık yazıldı. (1) Uyarı, eleştiri ve haber videoları uygulama göstermese de **dahil** (3.2). (2) Video türüne **6 — Haber / TV kesiti** eklendi; haberde uygulayıcı = konuşan uzman (6.2, 6.3). (3) Ses vurgusu ve ses yorumu netleşti (6.4). (4) Ticari yönlendirmede video açıklaması da okunur (6.6). (5) Hastalık adı kuralı etiketlere genişletildi (v2.1'de kaldırıldı). (6) mDISCERN 2 ve JAMA Yazarlık'ta kanal adındaki unvan yeterlidir (6.8).

1. Bir bakışta çalışma

Soru	Türkçe YouTube'daki boyun manipülasyonu ("kütletme", "kayropraktik", "omur yerine oturtma") videolarında hangi vaatler veriliyor ve bunların ne kadarı bilimsel kanıtın dışında? Vaatleri en çok kim veriyor? Risk anlatılıyor mu?
Tasarım	Kesitsel içerik analizi; **vaat düzeyinde** kodlama
Video havuzu	8 Türkçe arama terimi × ilk 50 sonuç, **Shorts dahil**. Ön taramada ~261 tekil aday (çoğu 10–60 sn)
Ölçekler	Vaat listesi (her vaat önceden kanıt sınıfına bağlı: A/B/C/D) · güvenlik bildirimi · gösteri öğeleri · mDISCERN (0–5) · JAMA (0–4) · GQS (1–5)
Kodlayıcılar	İki FTR hekimi. Önce 15 videoluk ön pilot, sonra tek turda bağımsız ve birbirine kör kodlama, sonda uzlaşı turu
Etik	Herkese açık veri, insan katılımcı yok, yorum toplanmıyor. Etik kurul gerekmez, makalede beyan edilir
Kodlama yükü	~261 aday (bir kısmı ilk soruda elenir), çoğu 10–60 sn. Video başına ~2 dk → kişi başı ~8–10 saat, birkaç güne bölünebilir

2. Neden bu çalışma?

2.1 Literatür

- **Arslan ve ark. 2023** (*J Man Manip Ther* 31(6):449–455): İngilizce **bel** manipülasyonu videoları, ilk 50. Tarif puanı 2,40/6, JAMA 2,14/4. Meslek grupları arasında fark yok. Uyarı ve kontrendikasyon nadiren anlatılmış.
- **Is ve ark. 2024** (*Int J Osteopath Med* 54:100734): 113 manuel tıp/terapi videosu; hekim, fizyoterapist, osteopat ve kayropraktör arasında puan farkı yok. Kalite orta-zayıf.
- **Zheluk ve ark. 2022** (*Cureus* 14(1):e21404): TikTok bel ağrısı; kayropraktör videoları en çok izlenen ve kılavuza en az uyan.

- **Üst servikal manuel terapi YouTube** (Research Square ön baskı 2026, hakemsiz): İngilizce 73 video; kılavuz uyumu düşük; bilgilendirilmiş onamı vurgulamayan videolar daha çok izleniyor. Vaatlere bakmıyor.
- **Kas-iskelet dışı iddialar yalnız web siteleri ve Twitter'da incelenmiş:** Ernst ve Gilbey 2010 (5 ülke, 200 kayropraktör sitesinin %95'inde dayanaksız iddia); Fransa 2021 (%79); Danimarka 2020; Alberta 2019 (%33 "subluksasyon"); COVID-19 bağışıklık iddiaları Twitter'da (Kawchuk 2020, 2023). **Videolarda vaat sınıflaması yapılmamış.**
- **Meslek karşılaştırması:** Simpson ve ark. 2019 (Avustralya, site + Facebook): yanıltıcı iddia kayropraktörlerde %57, **fizyoterapistlerde %20** (majör yanıltıcı yok). Video çalışmalarında (Arslan 2023, Is 2024) meslekler arasında fark bulunmamış.
- **Ses inancı:** Demoulin ve ark. 2018: halkın %49'u kütleme sesini omurun yerine oturmasına bağlıyor, %40'ı başarı göstergesi sayıyor.
- **Reardon ve ark. 2025** (*Cureus* 17(10):e93728): Kayropraktik ile kulak iltihabı tedavisi videoları; 42/50 kayropraktörden, yarısında "Östaki tüpünü düzeltme" iddiası.
- **Türkçe** manipülasyon/kütletme videolarını inceleyen bir çalışma, 25.10.2026'da PubMed, Europe PMC, DergiPark, TR Dizin ve YÖK Tez Merkezi'nde iki ayrı tarayıcı (Claude ve Codex) tarafından **bulunamadı**. Uluslararası tarama (PubMed + Europe PMC, 810 kayıt) ayrıntısı: `01_Literatur/uluslararasi_literatur.md`.

2.2 Farkımız

1. **İlk Türkçe boyun manipülasyonu video çalışması.** Türkçe izleyicinin karşılaştığı içerik, İngilizce çalışmalardan çıkarılamaz.
2. **Vaat düzeyinde doğruluk.** Önceki çalışmalar videoya genel bir kalite puanı verir. Biz videodaki her vaadi, önceden hazırlanmış bir **kanıt haritasına** göre sınıflıyoruz (Ek B).
3. **Shorts dahil.** Bu tür neredeyse tamamen Shorts'ta yaşıyor (ön taramada adayların %89'u 3 dakikanın altında).
4. **Gösteri öğeleri.** Kütleme sesinin öne çıkarılması, "imana geldi" tipi tepki ve önce-sonra sunumu ayrıca kodlanıyor. Bu öğeler, sesin başarı göstergesi olduğu yanılgısını besliyor.
5. **Uygulayıcı mesleği ve yetki.** Türkiye'de kayropraktik, GETAT Yönetmeliği (RG 27.10.2014/29158) kapsamında sertifikalı tabip ya da tabip gözetiminde uygulanır. Videolardaki uygulayıcı kimliği bu çerçevede betimlenir.

Hipotezler (kodlama başlamadan dondurulur):

- **H1:** Kanıt dışı vaat (en az bir B, C ya da D vaadi) içeren videolar, içermeyenlerden daha çok izlenir (günlük izlenme).
- **H2a (birincil):** Türkçe izleyicinin karşılaştığı kanıt dışı vaatlerin çoğu fizyoterapist unvanlı uygulayıcıların videolarından gelir. *(Maruziyet yükü sorusu; yürütücünün klinik gözlemi.)*
- **H2b (betimsel; test edilmez):** Manipülasyonu uygulayan ya da öneren videolarda (video türü 1–3) uygulayıcı dağılımı ve her grupta kanıt dışı vaat içeren video oranı; hekim videoları ayrıca video türüne göre (gösterim mi, uyarı mı) betimlenir. *(Arslan 2023 ve Is 2024'teki "meslekler arasında fark yok" bulgusu ile Simpson 2019 bulgusunun yanına konur.)*
- *Neden H2b test edilmiyor?* Ön taramada (8 terim × 50 ve 51–100 aralığı) Türkçe hekim videolarının çoğu uyarı videosuydu ("Boyun kütletme tehlikeli mi?"). Manipülasyonu gösteren ya da öven hekim videosu yaklaşık 5–7 idi ve neredeyse tümü tek bir kanaldan geliyordu. Kanal kümelenmesi düzeltildiğinde hekim grubu 1–2 kanala iner; bu durumda bir test mesleği değil tek bir uygulayıcının üslubunu ölçer. Bu nedenle fizyoterapist–hekim karşılaştırması kodlama başlamadan **betimsel** olarak önceden belirlenmiştir (CZY onayı 25.10.2026).
- **H3:** Videoların azında (<%20) herhangi bir risk ya da kontrendikasyon bilgisi verilir.

3. Videoların bulunması ve seçilmesi

Bu bölümü CZY/Claude yürütür; kodlayıcılar için bilgi amaçlıdır.

3.1 Arama

- **Tarih:** 25.10.2026, tek seferde. 8 × 100 → 515 tekil video; analiz kümesi (herhangi bir terimde ilk 50) **261** video (210 Shorts, 95 kanal). Liste dondurulduu; kodlama sırası sabit tohumla (20261025) karıştırıldı.
- **Yöntem:** YouTube Data API v3 (`search.list`), `regionCode=TR`, `relevanceLanguage=tr`, `order=relevance`, `type=video`. Kişisel arama geçmişinin etkisi olmaz, yeniden üretilebilir.
- **Terimler** (her birinden ilk 50):

    1. boyun kütletme
    2. boyun çıtlatma
    3. boyun manipülasyonu
    4. kayropraktik boyun
    5. chiropractic boyun
    6. boyun düzleşmesi kütletme
    7. omur yerine oturtma boyun
    8. boyun fıtığı manipülasyon

- Her terimden ilk 100 kaydedilir, analize ilk 50 alınır (51–100. sıralar yalnız ön pilot için). Liste CSV olarak **dondurulur**. Birden çok terimde çıkan video tek kayıttır; çıktığı terimler not edilir.
- Ön tarama (25.10.2026): 8 × 30 → 160, 8 × 50 → ~261, 8 × 100 → ~511 tekil aday. Her terim özgün video katıyor; hiçbiri gereksiz değil. İlk 100'e çıkmak iş yükünü ikiye katlıyor ama hekim içerikli uygulama videosu sayısını artırmıyor (alt sıralardaki hekim videoları da çoğunlukla uyarı videosu) → **ilk 50**.

3.2 Dahil etme ve dışlama

Otomatik ön eleme: tekrar, 60 dakikadan uzun.

Dil kuralı (kodlayıcı uygular): Türkçe konuşma **ya da** Türkçe ekran yazısı/başlık yoksa video hariç. Yalnız Türkçe etiket (#boyunkütletme) yetmez. Bu kural, Türkçe aramada çıkan yabancı kayropraktör kanallarını dışarıda bırakır.

Kodlayıcı formda **ilk soru olarak** değerlendirir. Video şu durumlarda **dışlanır**:

- **Boyun manipülasyonu yok.** Yalnız egzersiz, germe, masaj, mobilizasyon ya da cihaz anlatılıyor; kütletme/itme (thrust) uygulaması gösterilmiyor **ve konu edilmiyor**. Kütletmeyi anlatan, uyaran ya da haber yapan video bu nedenle dışlanmaz.
- **Yalnız başka bölge.** Yalnız bel, sırt, kulunç (torakal), parmak, çene ya da tüm vücut uygulaması var, boyun yok.
- **Kemik kırığı, çıkık ya da cerrahi** anlatımı (ör. klavikula kırığı).
- **Alet ya da ürün denemesi** ve boyuna elle uygulama yok (ör. "kütletme aleti denedim"). *Not:* Alet boyuna uygulanıp vaat veriliyorsa dahil edilir.
- Sessiz ve yazısız, hiçbir vaat ya da bilgi yok **ve** uygulayıcı belirlenemiyor.
- Video açılmıyor.

Karışık videolar: Tüm vücut kayropraktik videosunda boyun manipülasyonu da gösteriliyorsa **dahil**. Vaatler videonun tamamından kodlanır (izleyici vaadi bölgeye ayırmaz).

Uygunluk videonun kendisine göre verilir. Açıklama, etiket ya da başlıkta "boyun", "kayropraktik" geçmesi tek başına dahil etmeye yetmez; videoda boyun manipülasyonu gösterilmiyor ya da anlatılmıyorsa hariç (uygun neden:

manipülasyon yok / yalnız başka bölge). Açıklama, ancak video dahil edildikten sonra vaat kaynağı olarak okunur (CZY 29.10.2026).

Anlatan, uyaran ve haber videoları dahildir (v2.0). "Boyun manipülasyonu yok" yalnız kütletmenin hiç gösterilmediği **ve hiç konu edilmediği** video içindir. Boyun kütletmeyi anlatan, risklerini tartışan, "zararlı mı?" sorusunu yanıtlayan ya da haber yapan video, hastaya uygulama göstermese de **dahil** edilir; türü 5 (uyarı/eleştiri) ya da 6 (haber). Örnek: "Boyun kütletmek zararlı mıdır?" diye anlatan hekim videosu → dahil, tür 5. "Boyun kütletme faciası" haberi → dahil, tür 6.

Mizah ve eğlence videoları: Boyun manipülasyonu gösteriliyorsa **dahil**. Bu türün önemli bir kısmı eğlence biçiminde dolaşıyor; video türü 6.3'te ayrıca kodlanır.

3.3 Shorts

Shorts **dahil** ve ayrı bir katman olarak raporlanır. Shorts tespiti script ile yapılır (`youtube.com/shorts/<kimlik>` yanıtı).

4. Kodlama süreci

4.1 Roller

Rol	Kişi
Kodlayıcı 1	Dr. Öğr. Üyesi Cem Zafer Yıldır (FTR)
Kodlayıcı 2	Uzm. Dr. Mehmet Ercan (FTR)
Üçüncü hakem	Gerekirse sonradan belirlenir; çözülemeyen madde sayısı raporlanır

4.2 Adımlar

0. **Ön pilot (15 video, örneklem dışı).** Arama listesinin yalnız 51–100. sıralarda çıkan videolarından; havuz sabit tohumla karıştırılır, ön süzgeçten (Türkçe iz + başlık/açıklamada boyun ve kütletme/manipülasyon sözcüğü) geçen ve kanal başına en fazla 2 olacak biçimde ilk 15 video iki kodlayıcı tarafından bağımsız kodlanır. Amaç vaat listesinde eksik madde ve işlemeyen kural bulmaktır. Pilot sonrası kılavuz **bir kez** güncellenir (v2.0) ve **dondurulur**; ana kodlama sırasında değişmez. Pilot videoları analize girmez.
1. **Tek tur bağımsız kodlama** (tüm videolar). Formda izlenme ve beğeni sayısı **gösterilmez**. Bitince CSV CZY'ye gönderilir.
2. **Uzlaşı turu.** Farklı kodlanan maddeler kanıt alıntılarıyla yan yana gösterilir, birlikte karar verilir.
3. **Analiz** uzlaşılmış kodlarla; güvenilirlik uzlaşı öncesi bağımsız kodlarla.

Körleme sınırı: Kodlayıcı uygulayıcının kim olduğunu videoda görür; bu engellenemez. İki kodlayıcının da FTR hekimi olması, fizyoterapist videolarına karşı meslekî yanlılık eleştirisine açıktır. H2'nin yanlı kodlanmasını önlemek için vaatler **yalnız 6.7'deki listeden** işaretlenir. Vaat sınıfı (A/B/C/D) kodlayıcı tarafından değil, listeden **otomatik** belirlenir. Meslek ayrı bir soruda kodlanır.

4.3 İzleme kuralları

- Her video baştan sona izlenir; kısa videolar **en az iki kez**: bir kez sesli, bir kez yazılara bakarak. Ekrandaki yazılar, başlık ve açıklama vaadin en sık geçtiği yerlerdir.
- **Başlık, ekran yazısı, konuşma, video açıklaması ve sabitlenmiş kanal yorumu** vaat kaynağı sayılır. İzleyici yorumları sayılmaz.
- Video formun içindeki oynatıcıda izlenir; YouTube sayfasına gidilirse izlenme sayısı ve yorumlara bakılmaz.

5. Kodlama formu

Kalp yetmezliği çalışmasındaki formun aynısı: web bağlantısıyla açılır, kayıt otomatik, oturum sonunda "CSV indir". Ayrıntı e-postada.

6. Sorular ve karar kuralları

Sorular: **6.1 Uygunluk · 6.2 Uygulayıcı · 6.3 Video türü · 6.4 Gösteri öğeleri · 6.5 Güvenlik · 6.6 Ticari yönlendirme · 6.7 Vaatler · 6.8 mDISCERN · 6.9 JAMA · 6.10 GQS.**

Genel ilke: Videoda açıkça görülmeyen şey yok sayılır; tahmin edilmez.

6.1 Uygunluk

Dahil mi? Evet / Hayır (+ neden, bkz. 3.2).

6.2 Uygulayıcı / anlatan (tek seçim)

Boyun manipülasyonunu kim yapıyor ya da anlatıyor? Uygulayan ile anlatan farklıysa **uygulayan** esas alınır. Unvan videoda, açıklamada ya da kanal adında yazıyorsa kabul edilir.

Kod	Kategori	Ne zaman
1	Hekim — FTR	"Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon", "FTR uzmanı", "fizik tedavi uzmanı **Dr.**"
2	Hekim — diğer branş	Ortopedi, nöroşirürji, algoloji, aile hekimi vb.
3	Hekim — branş belirsiz	"Dr." var, branş yok
4	Fizyoterapist	"Fizyoterapist", "Fzt.", "PT", "Uzm. Fzt.", "Dr. Fzt."
5	Kayropraktör (yurt dışı diploma, DC)	"Chiropractor", "DC", "Kayropraktör" unvanı, hekim ya da fizyoterapist değil
6	Geleneksel / masör / "çıkıkçı" / spor eğitmeni	Sağlık meslek unvanı yok ama uygulamayı meslek olarak yapıyor
7	Bireysel / eğlence / kendi kendine	İçerik üreticisi, kendi boynunu kütleten, şaka videosu
8	Belirlenemiyor	Hiçbir yerde unvan yok, kim olduğu anlaşılmıyor

Karar kuralları:

- **"Kayropraktik" kelimesi meslek göstermez.** Kanal adı "Fizyoterapist X — Kayropraktik" ise → 4. "Kayropraktik sertifikalı" diyen bir hekim → 1–3.
- **Hekim (1–3) yalnız tıp hekimi olduğu doğrulanabilirse** seçilir: "Op. Dr.", "Uzm. Dr.", "Prof./Doç. Dr." + tıbbi branş ya da hastane künyesi. Unvanı tıbbi olmayan "Dr." (Dr. Fzt., Dr. Ody., doktoralı fizyoterapist, kanal adı "Dr. ..." ama kişi fizyoterapist) hekim **sayılmaz**.
- "Dr. Fzt." → 4 (hekim değil).
- "Fizik tedavi" ya da "fizyoterapi merkezi" adlı kanalda anlatan belirsizse → 8; açıklamaya kanal adını yazın.
- **Haber / TV videosu (v2.0):** Videoda kütletmeyi anlatan ya da uygulayan uzman esas alınır (altyazıdaki unvan). Haber kanalının kendisi uygulayıcı değildir; uzman yoksa → 8.

Ek soru — GETAT sertifikası anılıyor mu? Evet / Hayır. (Videoda, açıklamada ya da kanal adında "GETAT", "kayropraktik sertifikalı", "Sağlık Bakanlığı onaylı" ibaresi.)

6.3 Video türü (tek seçim)

Kod	Tür

1	**Uygulama gösterimi:** Uygulayıcı bir hastaya manipülasyon yapıyor
2	**Anlatım:** Konuşma ya da sunum ağırlıklı; uygulama yok ya da kısa
3	**Kendi kendine öğretim:** İzleyiciye kendi boynunu ya da yakınının boynunu kütletmeyi öğretiyor
4	**Eğlence / tepki / mizah:** Uygulama şaka, tepki ya da "challenge" biçiminde
5	**Uyarı / eleştiri:** Videonun ana mesajı kütletmenin riskleri ya da yanlış inanışlar
6	**Haber / TV kesiti:** Haber kanalı ya da TV programı; haber diliyle sunuluyor (uyarı içerse de 6)

6.4 Gösteri öğeleri (çoklu seçim)

- **Ses vurgusu:** Ses yükseltilmiş, yakın mikrofon, ekranda "çıt!", ses efekti, "sese dikkat", "ASMR"
- **Abartılı tepki:** Hastanın çığlığı, kahkahası ya da "imana geldi", "ruhu çıktı" tipi yazılar
- **Önce-sonra sunumu:** Aynı video içinde "önce/sonra" görüntüsü, ölçümü ya da beyanı
- **Hasta tanıklığı:** Hastanın "geçti", "duymaya başladım" gibi sözleri
- **Görüntüleme gösterimi:** Röntgen ya da MR gösterilerek uygulamanın gerekçesi sunuluyor
- **Ses yorumu (aşağıdaki iki seçenekten biri):**
    - Doğru: "ses eklemdeki gaz kabarcığından gelir, başarının ölçüsü değildir"
    - Yanlış: Ses başarı ya da "yerine oturma" kanıtı olarak sunuluyor ("ses geldi, oldu", "kireç kırıldı") → ayrıca **D7** vaadi olarak işaretlenir

Ses vurgusu (v2.0): Kısa uygulama videolarında kütletme sesi mikrofona yakın ve belirgin duyuluyorsa, ses ayrıca öne çıkarılıyorsa ya da başlıkta/etikette #asmr varsa işaretlenir.

Ses yorumu (v2.0): "Doğru" yalnız videoda sesin ne olduğu **açıkça söyleniyorsa** seçilir. Hiç söz ya da yazı yoksa "Ses yorumlanmıyor". Konuşma ya da yazı yokken D7 verilmez; kodlayıcı kendi yorumunu ("video zaten on saniye") vaat diye yazmaz.

6.5 Güvenlik bildirimi (çoklu seçim)

- **Risk anılıyor:** İnme, damar yaralanması, baş dönmesi, ağrı artışı vb. herhangi bir risk
- **Kontrendikasyon ya da kimlere yapılmaz:** Osteoporoz, romatoid artrit, damar hastalığı, travma, çocuk vb.
- **Öncesinde muayene/tetkik gerektiği** söyleniyor
- **"Evde kendiniz yapmayın"** uyarısı
- **Tehlikeli öneri** *(yanıltıcı)*: Evde, kendi kendine ya da yakınına kütletme teşviki; boyun sıkıştırarak ya da çekerek uygulama tarifi
- **"Riski yok / tamamen güvenli"** iddiası *(yanıltıcı)*

6.6 Ticari yönlendirme (çoklu seçim)

Fiyat · Randevu / WhatsApp / telefon · Adres / klinik tanıtımı · Ürün satışı · Kurs / sertifika satışı · Yok

Video açıklamasını mutlaka açın (v2.0). Açıklamada ya da sabitlenmiş yorumda randevu telefonu, WhatsApp bağlantısı, adres ya da klinik tanıtımı varsa, videonun içinde geçmese de işaretlenir.

6.7 Vaatler (ana değişken)

Vaat nedir? Manipülasyonun, izleyici ya da hasta için **bir sonuç** sağlayacağını ya da **bir mekanizmayla** çalıştığını söyleyen ifade. Başlık, ekran yazısı, konuşma, açıklama ya da hasta tanıklığında geçebilir. Hasta tanıklığı da uygulayıcının yayımladığı içerikte geçtiği için vaat sayılır.

Nasıl kodlanır? Aşağıdaki listeden videoda geçen her vaadi işaretleyin ve kanıt kutusuna **vaadin nerede geçtiğini + kısa alıntı** yazın. Yer: başlık, ekran yazısı, konuşma, açıklama ya da hasta. Örnek: *"ekran yazısı — 'atlas hizalandı,*

kulak açıldı'". **Dakika:saniye yalnız 2 dakikadan uzun videolarda yazılır** (ör. *"3:15 konuşma — 'fıtığı içeri ittik'"*); kısa videolarda isteğe bağlıdır (CZY 29.10.2026). Kanıt kutusu boş vaat kaydedilmez. **Sınıfı (A/B/C/D) siz seçmezsiniz; form, Ek B'deki kanıt haritasına göre kendisi atar.**

Listede olmayan bir vaat varsa **"Z — Diğer vaat"** seçip alıntıyı yazın. Sınıfı uzlaşı turunda kanıt haritasına göre verilir.

A — Kanıtla uyumlu (abartısız)

Kod	Vaat	Örnek
A1	Boyun ağrısında **kısa süreli** rahatlama	"Ağrınızı bir süre hafifletebilir", "rahatlama sağlar"
A2	Boyun hareketinde kısa süreli artış	"Boynunuz daha rahat döner"
A3	Boyun kaynaklı (servikojenik) baş ağrısında kısa süreli azalma	"Boyundan kaynaklanan baş ağrısında yardımcı olabilir"
A4	Egzersiz ya da tedavi programının **parçası** olarak sunuluyor	"Tek başına yetmez, egzersizle birlikte"

B — Abartılı (kas-iskelet sorunu ama kanıtın ötesinde)

Kod	Vaat	Örnek
B1	**Kalıcı** ya da **tek seansta** çözüm	"Tek hareketle bitir", "bir seansta geçti", "kesin çözüm"
B2	Boyun fıtığını tedavi etme, geri itme	"Fıtığı içeri ittik", "fıtığa son"
B3	Boyun düzleşmesini, eğriliğini ya da duruşu düzeltme	"Boyun düzleşmesi düzeldi", "lordoz geri geldi"
B4	Kol uyuşması / sinir sıkışması / radikülopatiyi tedavi	"Kol uyuşması gitti"
B5	Baş dönmesi / vertigo tedavisi	"Baş dönmesine son"
B6	Baş ağrısını (tür belirtmeden) tedavi etme	"Baş ağrısı bitti"
B7	Kireçlenme / kas spazmı / kulunç tedavisi (kesin dille)	"Kireçlenmeyi çözdük"

Kural: Aynı vaat **koşullu ve ölçülü** söyleniyorsa A'ya bakın ("kısa süreli rahatlama sağlayabilir"). **Kesin, kalıcı ya da hastalığı tedavi eden** bir dille söyleniyorsa B'dir.

C — Kanıtla çelişen (kontrollü çalışmalarda etki bulunmamış)

Kod	Vaat
C1	Tansiyonu düşürme
C2	Migreni tedavi etme
C3	Astım / solunum hastalığını düzeltme
C4	Bebek koliği, bebek ya da çocuk hastalıklarını tedavi
C5	Adet sancısı / jinekolojik sorunlar

D — Dayanaksız (destekleyen kontrollü kanıt yok; mekanizma iddiaları dahil)

Kod	Vaat
D1	**İşitme** kaybı, kulak tıkanıklığı, **kulak çınlaması**
D2	**Görme**, göz sorunları
D3	Reflü, mide-bağırsak, sindirim
D4	Uyku, kaygı, depresyon, "stres attı", odaklanma
D5	Bağışıklık, enerji, "toksin atma", genel sağlık
D6	**"Omur yerine oturdu / kayma düzeldi / atlas hizalandı"** (yapısal düzeltme)
D7	**Ses başarının göstergesi** ("ses geldi oldu", "kireç kırıldı", "tıkanıklık açıldı")
D8	"Sinir sıkışmasını açtım", "kan akımını / beyne giden kanı açtım" (mekanizma)
D9	Diğer kas-iskelet dışı hastalık (şeker, tiroid, kalp, nörolojik hastalık vb.)

Sınırda örnekler:

Durum	Kod
"Boyun tutulması olan hastamız, uygulamadan sonra rahatladı"	A1
"Boyun düzleşmesini tek hareketle bitir"	B1 + B3
"Atlas terapisiyle işitme kaybı düzeldi" (başlık)	D1 + D6
"Ses geldi, omur yerine oturdu"	D6 + D7
"Ses eklemdeki gazdan gelir, önemli olan ses değil"	Vaat yok; 6.4'te ses yorumu = doğru
"Migren hastamız" (başlık), başka söz yok	Vaat yok (yalnız hastalık adı; v2.1)
"Migren hastamız, uygulamadan sonra ağrısı geçti"	C2
Hasta "kulağım açıldı" diyor, uygulayıcı düzeltmiyor	D1
Hiç konuşma ya da yazı yok, yalnız uygulama ve ses	Vaat yok; 6.4'te ses vurgusu
Açıklamada "boyun ağrısı, kayropraktik, #boyunkütletme"	Vaat yok
Açıklamada "#boyunağrısı #migren #kulakçınlaması"	Vaat yok (etiket; v2.1)
Başlık: "Boyun fıtığı hastamız"	Vaat yok (yalnız hastalık adı; v2.1)
Uyarı videosu: "Kütletme kulak açar diyorlar, bu doğru değil"	Vaat yok; tür 5
Eleştiri videosu başkasının kesitini gösterip reddediyor (kesitte "fıtığı ittik")	Vaat yok
"Çıkıkçılar yanlış yapıyor, bizim tekniğimizle fıtık geçer"	B2 (kendi vaadi)
Kesit gösteriliyor, reddedilmeden geçiliyor ("ilginç")	Kesitteki vaat kodlanır
Başlık: "BOYUN DÜZLEŞMESİ EGZERSİZLERİ. KAYROPRAKTİK"	Vaat yok (konu başlığı; pilot uzlaşısı)
Başlıkta etiket: "Servikal manipülasyon #boyunfıtığı"	Vaat yok (etiket; pilot uzlaşısı)
Başlık: "BOYUN KÜTLETME. BOYUN FITIĞI EGZERSİZLERİ"	Vaat yok (pilot uzlaşısı)
Açıklamada anahtar sözcük dizisi: "…KULAK ÇINLAMASI TEDAVİSİ. ATLAS KEMİĞİ TEDAVİSİ. BOYUN DÜZLEŞMESİ TEDAVİSİ…"	Vaat yok (cümle değil, sözcük listesi; pilot uzlaşısı)
Başlık: "#Boyun ağrısı çekenler", başka söz yok	Vaat yok (yalnız boyun ağrısı; pilot)
Başlık: "Boyun/trapez ağrısı için osteopatik çözümler"	Vaat yok (genel "çözüm" sözü; pilot uzlaşısı)
10 saniyelik uygulama, söz ya da yazı yok	Vaat yok; D7 değil; ses yorumu "yorumlanmıyor" (pilot)

Hastalık adı ve etiket kuralı (v2.1, pilot uzlaşısı; 29.10 kuralının yerine): Başlıkta, açıklamada ya da etikette bir hastalık ya da yakınmanın **yalnız adının** geçmesi vaat **değildir**; boyun ağrısı dışı adlar (fıtık, düzleşme, migren, kulak çınlaması, baş dönmesi…) için de böyledir. Açıklamadaki anahtar sözcük dizileri ("BOYUN FITIĞI EGZERSİZLERİ. KULAK ÇINLAMASI TEDAVİSİ. ATLAS KEMİĞİ TEDAVİSİ…") ve etiketler (#boyunfıtığı, #migren) de vaat sayılmaz. Vaat için manipülasyonun **bir sonuç sağladığını** ya da **bir mekanizmayla çalıştığını** söyleyen bir ifade gerekir: konuşma, ekran yazısı, açıklamadaki cümle ya da hasta tanıklığı ("fıtığı içeri ittik", "kulağım açıldı", "migrene son", "ağrınız rahatlar").

Genel "çözüm" sözü yetmez (v2.1). "Boyun ağrısı için çözümler" gibi konu başlığı biçimindeki söz vaat değildir; sonuç açıkça söylenmelidir. "Kesin çözüm", "tek seansta çözüm" gibi kesin ya da kalıcı sonuç iddiası ise B1'dir.

Eleştiri ve aktarma kuralı: Vaat, videonun kendisinin **doğru diye sunduğu** iddiadır. Başkasının iddiası aktarılıp **reddediliyorsa** vaat sayılmaz. Eleştiri, videonun kendi verdiği vaadi ortadan kaldırmaz. Reddedilmeden gösterilen iddia, izleyiciye düzeltilmeden ulaştığı için vaat sayılır. Net değilse en yakın seçenek + Açıklama (CZY 29.10.2026).

6.8 mDISCERN (0–5) · 6.9 JAMA (0–4) · 6.10 GQS (1–5)

Tanımlar ve karar kuralları kalp yetmezliği çalışmasının kılavuzuyla **aynıdır** (Singh 2012; Silberg 1997; Bernard 2007). Bu çalışmaya özgü eklemeler:

- **mDISCERN 2 (güvenilir kaynak):** Adı ve unvanı belli **hekim ya da fizyoterapist** kabul edilir. Unvan tek başına kaynak sayılır; mesleğe göre fark gözetilmez. **Kanal adındaki unvan ya da klinik/kurum adı yeterlidir** ("Fizyoterapist X", "Op. Dr. X", "Dr. Fizyoo", "Eska Fizyoterapi") → Evet (v2.1). Unvansız kişi adı ya da bilgisiz kanal → Hayır.
- **JAMA Yazarlık (v2.1):** Kanal adında kişinin adı + unvanı, yalnız unvan ("Dr. Fizyoo") ya da klinik/kurum adı ("Eska Fizyoterapi") varsa → Var. Unvansız kişi adı ya da kimin yayımladığı belli değilse → Yok.

- **mDISCERN 3 (dengeli):** Yarar yanında **hiçbir risk ya da sınır** anılmıyorsa → Hayır.
- **GQS soru cümlesi:** "Boyun ağrısı için bilgi arayan bir hasta için bu video ne kadar kaliteli ve yararlı?"
- **GQS sınırı:** C ya da D vaadi varsa ya da 6.5'te tehlikeli öneri varsa GQS en fazla **2** olur.
- **Kısa videolar:** Aynı kurallarla puanlanır. 15 saniyelik videoların çoğunun düşük puan alması beklenir; kısa olduğu için puan eklenmez.

6.11 Açıklama kutusu

Kararsız kaldığınız her şey.

7. Otomatik toplanan veriler (kodlayıcı görmez)

Video kimliği, başlık, kanal, yükleme tarihi, süre, Shorts mı, izlenme, beğeni, yorum sayısı, abone sayısı, terim ve sıra. Türetilmiş: günlük izlenme, beğeni oranı.

8. İstatistik planı

8.1 Güvenilirlik (bağımsız kodlarla)

- Uygulayıcı, video türü: Cohen κ
- **Video düzeyinde "en az bir B–D vaadi var mı?"** (ana değişken): Cohen κ + uyum yüzdesi + Gwet AC1 (kappa paradoksu için)
- Vaat kategorisi düzeyinde (her kod için var/yok): κ, yalnız en az 10 videoda geçen kodlar için. Seyrek kodlarda yalnız uyum yüzdesi
- GQS: kuadratik ağırlıklı κ; mDISCERN ve JAMA toplamları: ICC(2,1)

8.2 Ana analizler (uzlaşılmış kodlarla)

1. **Betimsel:** Uygulayıcı ve tür dağılımı; vaat kodlarının sıklığı; **kanıt dışı vaat içeren video oranı** (Wilson %95 GA); video başına vaat sayısı; en yüksek sınıf (A/B/C/D); güvenlik bildirimi oranları; gösteri öğeleri. Shorts ve uzun videolar ayrı katman olarak.
2. **H1:** Kanıt dışı vaat içeren ve içermeyen videolarda günlük izlenme ve beğeni oranı (Mann–Whitney U, etki büyüklüğü r).
3. **H2a:** Kanıt dışı vaat içeren videoların uygulayıcıya göre dağılımı (fizyoterapist payı, Wilson %95 GA) ve her meslek grubunda kanıt dışı vaat içeren video oranı. Ayrıca mesleğe göre video türü dağılımı (ki-kare/Fisher).
4. **H2b (betimsel):** Yalnız video türü 1–3 (uygulama gösterimi, anlatım, kendi kendine öğretim) videolarında uygulayıcı dağılımı (Wilson %95 GA) ve her meslek grubunda kanıt dışı vaat içeren video oranı (küme bootstrap GA). **Oran video başına verilir, ham sayı karşılaştırılmaz.** Hekim videoları video türüne göre ayrıca tablolanır. **Fizyoterapist–hekim farkı için hipotez testi yapılmaz** (önceden belirlenmiş karar; gerekçe 2.2). Diğer gruplar (kayropraktör, geleneksel, bireysel) de betimsel verilir.
5. **Kanal kümelenmesi:** Aynı kanaldan çok video çıkabilir. Oranların GA'ları **kanal düzeyinde küme bootstrap** ile (2000 tekrar, sabit tohum) verilir. Duyarlılık analizi: kanal başına bir video (sabit tohumla rastgele) ile H1 ve H2a yeniden hesaplanır, H2b tabloları yinelenir.
6. **H3:** Herhangi bir güvenlik bildirimi olan video oranı (Wilson GA); %20 eşiğiyle tek örneklem binom testi.
7. **Keşifsel:** Shorts ile uzun videolarda kanıt dışı vaat oranı; ses vurgusu ile izlenme ilişkisi; arama terimine göre dağılım. Kanıt dışı vaati yordayan etmenler için lojistik regresyon, yalnız değişken başına en az 10 olay varsa.

$p < 0,05$ (iki yönlü). Birden çok terimde çıkan video bir kez sayılır.

9. Etik ve veri koruma

- Herkese açık videolar; insan katılımcı yok; yorum toplanmıyor → etik kurul gerekmez, makalede gerekçesiyle beyan edilir.
- Makalede **kanal ve uygulayıcı adı verilmez**; alıntılar kimliği belli etmeyecek biçimde kısaltılır.
- Mevzuata ilişkin cümleler (GETAT, mesleki yetki) yalnız mevzuat metnine dayanılarak ve betimsel yazılır; tek tek uygulayıcılar hakkında yetki yargısı kurulmaz.

10. Takvim (taslak)

Hafta	İş
0	Kılavuz v1.2 onayı, arama günü, liste dondurma, form
0–1	Ön pilot (15 video) → kılavuz v2.0 dondurulur
1–3	Bağımsız kodlama
4	Uzlaşı + analiz
5–7	Makale

11. Kaynaklar (kanıt haritası kaynakları Ek B'de)

1. Arslan S, Dinç E, Arslan T. Are YouTube videos claiming to describe lumbar spinal manipulation techniques adequate? J Man Manip Ther. 2023;31(6):449-455. doi:10.1080/10669817.2023.2244398
2. Is EE, Tarihci Çakmak E, Korkmaz MD. Evaluating the information quality of YouTube videos on manual medicine/therapy. Int J Osteopath Med. 2024;54:100734. doi:10.1016/j.ijosm.2024.100734
3. Zheluk A, Anderson J, Dineen-Griffin S. Analysis of acute non-specific back pain content on TikTok: an exploratory study. Cureus. 2022;14(1):e21404. doi:10.7759/cureus.21404
4. Reardon L, Gawel EM, Sharma S, ve ark. Misinformation in YouTube videos about chiropractic treatment for otitis media. Cureus. 2025;17(10):e93728. doi:10.7759/cureus.93728
5. Singh AG, Singh S, Singh PP. YouTube for information on rheumatoid arthritis — a wakeup call? J Rheumatol. 2012;39(5):899-903.
6. Silberg WM, Lundberg GD, Musacchio RA. Assessing, controlling, and assuring the quality of medical information on the Internet. JAMA. 1997;277(15):1244-1245.
7. Bernard A, Langille M, Hughes S, ve ark. A systematic review of patient inflammatory bowel disease information resources on the World Wide Web. Am J Gastroenterol. 2007;102(9):2070-2077.
8. Simpson JK, et al. At-risk advertising by Australian chiropractors and physiotherapists. Chiropr Man Therap. 2019;27:30. doi:10.1186/s12998-019-0247-x
9. Ernst E, Gilbey A. Chiropractic claims in the English-speaking world. N Z Med J. 2010;123(1312):36-44.
10. Demoulin C, et al. Beliefs in the population about cracking sounds produced during spinal manipulation. Joint Bone Spine. 2018;85(2):239-242. doi:10.1016/j.jbspin.2017.04.006
11. Gonçalves G, et al. Chiropractic website claims related to non-musculoskeletal conditions: a cross-sectional study. Chiropr Man Therap. 2021;29:39. doi:10.1186/s12998-021-00397-y
12. Kawchuk G, et al. Misinformation about spinal manipulation and boosting immunity: an analysis of Twitter activity during the COVID-19 crisis. Chiropr Man Therap. 2020;28:34. doi:10.1186/s12998-020-00319-4
13. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği. Resmî Gazete, 27.10.2014, sayı 29158.

Ek A. Hızlı başvuru kartı

Soru	Kısa kural
Dahil mi?	Boyuna kütletme/itme uygulaması **gösteriliyor ya da anlatılıyor** mu? Yalnız egzersiz/masaj/bel → hariç
Uygulayıcı	Uygulayana göre; "kayropraktik" kelimesi meslek değildir; Dr. Fzt. = 4
Video türü	Gösterim / anlatım / kendi kendine / eğlence / uyarı
Gösteri	Ses vurgusu, tepki, önce-sonra, tanıklık, görüntüleme, ses yorumu
Güvenlik	Risk, kontrendikasyon, muayene, "evde yapmayın"; tehlikeli öneri ve "riski yok" yanıltıcıdır
Vaatler	Geçen her vaadi listeden işaretle + **yer ve alıntı** (dakika yalnız >2 dk videoda). Sınıfı form verir. Ölçülü dil → A; kesin/kalıcı/tedavi → B; tansiyon, migren, astım → C; işitme, görme, "yerine oturdu", "ses geldi oldu" → D
mDISCERN / JAMA / GQS	KY kılavuzu; C/D vaadi ya da tehlikeli öneri varsa GQS ≤ 2

Ek B. Kanıt haritası (vaat sınıflarının dayanağı)

Başlık	Kaynak	Bulgu	Kesinlik	Sınıf
Boyun ağrısı	Gross ve ark. Cochrane 2015, CD004249, doi:10.1002/14651858.CD004249.pub4; Carrasco-Uribarren ve ark. 2024, Musculoskelet Sci Pract 71:102927	Etkisiz kontrole karşı kanıt az; tek seansın etkisi hemen sonrasıyla sınırlı. Aktif tedavilerle benzer	Düşük / çok düşük	Kısa süreli rahatlama **A**; kalıcı/tek seans **B**
Servikojenik baş ağrısı	Gross 2015; sham kontrollü MA 2022 (PMC9682850)	Kısa dönemde sham'dan iyi; uzun dönemde fark yok	Düşük – orta	Kısa süreli **A**; türsüz "baş ağrısı biter" **B**
Servikal radikülopati	Plener ve ark. 2023, Clin J Pain 39(3):138-146	Belirli bir manipülasyon tekniği için etki kesin değil	Düşük / çok düşük	**B**
Servikojenik baş dönmesi	De Vestel ve ark. 2022 (PMC9487935); 2025 MA, BMC Musculoskelet Disord, doi:10.1186/s12891-025-08899-z	Manuel terapinin baş dönmesine etkisi; tanı ölçütleri ve teknikler değişken	Düşük – orta	Kesin dille **B**
Kas-iskelet dışı	Côté ve ark. 2021, Chiropr Man Therap, doi:10.1186/s12998-021-00362-9	Hipertansiyon, migren, astım, kolik, dismenore: sham'a üstünlük yok	Kabul edilebilir/yüksek kaliteli 6 RKÇ	**C**
İşitme, tinnitus, görme, reflü, bağışıklık vb.	Côté 2021	Kontrollü kanıt yok	—	**D**
Kütleme sesi	Moorman ve Newell 2022, Chiropr Man Therap 30:42, doi:10.1186/s12998-022-00454-0	Sesin varlığı ağrı sonucunu öngörmüyor	Sınırlı (5 çalışma)	"Ses = başarı" **D**
"Omur yerine oturtma"	Biyomekanik SD 2025 (PubMed 40680063)	Hareket açıklığındaki değişim, omurun "yerine oturması" demek değil	Destekleyen kanıt yok	**D**
Güvenlik	Pankrath ve ark. 2024 (PubMed 38805524); Cassidy ve ark. 2008, Spine, doi:10.1097/BRS.0b013e3181644600; IFOMPT Servikal Çerçeve 2020/2023	RKÇ'lerde hafif yan etkiler; nadir ciddi risk (arter diseksiyonu) nicelenemiyor;	—	"Riski yok" **yanıltıcı** (6.5)

		tarama testleri yetersiz		

Kaynakların künyeleri Codex ve Claude taramasıyla doğrulandı (`01_Literatur/codex_tarama.md`). Makaleye girmeden önce Crossref'ten bir kez daha doğrulanacak.